

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Introdução: Um Caso Histórico

O ano é 1962. Você está em Cambridge e um aluno da graduação de Física chega no ambulatório da faculdade com a seguinte queixa: "Doutor, estou me sentindo muito estranho. Ando caindo, ando fraco e ultimamente estou com dificuldade de engolir alimentos sólidos."

Você vai examinar o paciente e, conhecendo ele e sabendo que ele é um aluno brilhante, seu mundo cai. Ele apresenta **hiperreflexia** em membro inferior e membro superior, mas ao mesmo tempo tem **fasciculação e atrofia** de membro inferior. Você percebe também que a voz dele está estranha, com uma leve disartria.

Esse paciente apresentava achados de **síndrome de primeiro E de segundo neurônio motor simultaneamente** - o que indicava uma síndrome gravíssima que poderia levar à perda de funcionalidade rapidamente. E o paciente era muito jovem, com 20 e poucos anos.

Esse paciente era **Stephen Hawking**. A doença que ficou muito famosa por conta dele, mas é importante lembrar que o caso dele foi **extremamente atípico** - início muito precoce e evolução muito lenta. Ele viveu até os 76 anos, quando a maioria dos pacientes evolui a óbito em menos de um ano do diagnóstico.

Conceito e Epidemiologia

A **Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)** é uma doença **neurodegenerativa** que acomete tanto o **primeiro quanto o segundo neurônio motor**.

Epidemiologia:

- Aproximadamente 2 casos por 100.000 habitantes (não é tão rara)
- Discreta predominância masculina (relação quase 1,5:1)
- Início clássico na **6ª a 7ª década de vida** (60-70 anos)
- Evolução rápida - geralmente o paciente perde funcionalidade em questão de 6 meses

Fatores de risco:

- Idade avançada
- Tabagismo
- História familiar

Fisiopatologia: O Que É Acometido

A ELA acomete **simultaneamente**:

Primeiro neurônio motor:

- Via **corticospinal** (do córtex até a medula espinhal)
- Via **corticobulbar** (do córtex até o bulbo/tronco encefálico)

Segundo neurônio motor:

- **Corno anterior da medula**
- **Núcleos dos nervos cranianos** (principalmente bulbares)

Essa é a chave da doença: **acometimento concomitante de primeiro e segundo neurônio motor**. Nenhuma outra doença faz isso de forma tão característica.

Quadro Clínico: As Diferentes Apresentações

A clínica varia muito no **início**, mas todos os pacientes **evoluem da mesma forma** - progressão para insuficiência respiratória.

1. Início Bulbar:

- Paciente abre o quadro com **disartria** (fala arrastada) e **disfagia**
- **Atrofia e fasciculação de língua** - achado muito específico! Se suspeitar de ELA, avalie a língua do paciente
- Sialorreia (excesso de saliva por dificuldade de deglutição)
- Reflexo de náusea exacerbado

2. Início Cervical (mais comum):

- Fraqueza distal ou proximal de **membro superior**
- Perda de destreza manual
- Queda de objetos
- Por acometimento do corno anterior da medula cervical

3. Início Lombossacro:

- Acometimento predominante de **membro inferior**
- Paciente começa a cair, tropeçar
- Fraqueza para dorsiflexão do pé
- Atrofia de musculatura proximal muito marcada
- Foi o caso de Stephen Hawking - ele começou caindo, se machucando

4. Início Torácico (mais raro e mais grave):

- Já começa com **fraqueza da musculatura respiratória**
- Evolui a óbito geralmente em menos de 6 meses
- Prognóstico muito reservado

Achados ao Exame Físico: A Mistura de Sinais

O que torna a ELA única é a **coexistência de sinais de primeiro e segundo neurônio motor no mesmo paciente**:

Sinais de primeiro neurônio motor (síndrome piramidal):

- **Hiperreflexia**
- **Reflexos patológicos**: Babinski, Hoffman (equivalente do Babinski para membro superior - faz-se batendo no dedo médio)
- **Espasticidade**

Sinais de segundo neurônio motor (síndrome do neurônio motor inferior):

- **Atrofia muscular**
- **Fasciculações** (contrações visíveis sob a pele)
- **Câimbras**
- Pode ter até **arreflexia** em algumas áreas (parece contraditório, mas depende do estágio e localização)

Sintomas bulbares:

- Disfagia
- Disartria
- Dispneia

Sintomas cognitivos: Presentes em **50% dos casos**! Isso diferencia ainda mais o caso de Hawking, que manteve cognição preservada.

Evolução e Prognóstico

A evolução inerente da doença é o **acometimento da musculatura ventilatória**, levando a:

- Insuficiência respiratória
- Necessidade de suporte ventilatório (VNI, traqueostomia, ventilador)
- Óbito por complicações associadas

Principal causa de óbito: Pneumonia broncoaspirativa. O paciente perde a capacidade de controle de via aérea, aspira, desenvolve pneumonia e evolui a óbito.

Prognóstico: Geralmente o paciente evolui a óbito em **menos de 1 ano** do diagnóstico. É uma doença muito grave e de evolução rápida.

Tratamento

Infelizmente, **não existe tratamento curativo**. O manejo é:

1. Tratamento de suporte:

- Fisioterapia motora e respiratória
- Fonoaudiologia para disfagia e disartria
- Suporte nutricional (gastrostomia quando necessário)
- Suporte ventilatório

2. Manejo de complicações:

- Prevenção e tratamento de úlceras de decúbito
- Tratamento de pneumonias
- Manejo de secreções

3. Medicação específica:

- **Riluzol:** Única medicação aprovada que melhora a sobrevida em **até 6 meses**. Pouca coisa, mas é o que temos disponível.
- Existem novas medicações em pesquisa, mas ainda não disponíveis para uso clínico.

Resumo dos Gatilhos para Prova

ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica:

Apresentação: 4 formas de início:

- Bulbar (disartria, disfagia, atrofia de língua)
- Cervical (fraqueza de MMSS, queda de objetos)
- Lombossacro (fraqueza de MMII, quedas)
- Torácico (insuficiência respiratória precoce - pior prognóstico)

Clínica de primeiro neurônio motor:

- Hiperreflexia
- Reflexos patológicos (Babinski, Hoffman)
- Espasticidade

Clínica de segundo neurônio motor:

- Atrofia
- Fasciculações
- Câimbras
- Pode ter arreflexia

Sintomas bulbares:

- Disfagia
- Disartria
- Dispneia

Tratamento:

- Manejo de complicações + suporte
- Riluzol: melhora sobrevida em até 6 meses

Macete final: Paciente de 60-70 anos com fraqueza progressiva + sinais de primeiro neurônio motor (hiperreflexia, Babinski) + sinais de segundo neurônio motor (atrofia, fasciculações) = **ELA até que se prove o contrário.**